Buổi 2 (TÌM & ĐỌC): Đáp án và ghi chú hướng dẫn

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · Neudata · *Bản dành cho giảng viên. Không chia sẻ trước buổi học.*

Đáp án mẫu. Câu trả lời khác vẫn được chấp nhận nếu cụ thể và nhất quán.

Câu hỏi ôn tập: đáp án Buổi 1

1. **Bài báo 1 (Boulet 2024) là thử nghiệm** (RCT thí điểm, pilot RCT); **Bài báo 2 (Hyun 2023) là nghiên cứu thuần tập** (thuần tập ghép cặp từ hệ thống lưu trữ thông tin).
2. **P** người lớn bị sepsis · **E** cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày 3 · **C** cân bằng dịch trung tính hoặc âm · **O** tử vong · **T** trước ngày 28 (câu hỏi PECO: E = phơi nhiễm).
3. **Feasible (khả thi)**: kết cục tử vong cần hơn 1000 người bệnh.
4. **"Ước tính tỷ lệ người bệnh có cân bằng dịch dương vào ngày 3"**: động từ đo lường được. "Tìm hiểu" không đo lường được.
5. **H0:** cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5 như nhau khi dùng quy trình hạn chế dịch và khi chăm sóc thường quy.

Nếu nhiều học viên sai câu 4 hoặc 5, dành thêm một phút: mục tiêu cụ thể dùng động từ đo lường được; H0 luôn phát biểu "không có khác biệt".

Kiểm tra hiểu bài (phần 2.1): AND, OR hay NOT?

1. **AND** (septic shock AND fluid restriction). 2. **OR** (restrictive OR conservative). 3. **Ít hơn** (AND thu hẹp kết quả). 4. NOT loại mọi bài báo có nhắc đến trẻ em ở bất kỳ đâu, kể cả những nghiên cứu tốt ở người lớn chỉ nhắc đến trẻ em một lần.

Kiểm tra hiểu bài (phần 2.2): Đạt hay không đạt?

1. **Không đạt**: viết chắp vá là đạo văn kể cả khi có trích dẫn. 2. **Đạt** (nhưng hiếm gặp trong viết y khoa). 3. **Không đạt**: phát hiện của người khác cần trích dẫn. 4. **Không đạt**: bạn có thể lặp lại một sai sót, vì vậy hãy đọc và trích dẫn bản gốc.

Kiểm tra hiểu bài (phần 2.3): nhận diện spin

1. Từ chỉ quan hệ nhân quả cho một thiết kế quan sát. Viết lại thành *"cân bằng dịch dương có liên quan với tử vong cao hơn"*.
2. p = 0.31 không phải là bằng chứng về khác biệt. Viết lại thành *"không có khác biệt có ý nghĩa thống kê; khoảng tin cậy rộng"*.
3. Tiêu điểm là một kết cục phụ. Hãy mở đầu bằng kết quả chính.
4. Thay đổi trước–sau không có nhóm so sánh. Viết lại thành *"tử vong thấp hơn sau khi áp dụng; vì không có nhóm chứng, chúng tôi không thể quy kết điều này cho quy trình"*.

Bài tập 1: Xây chuỗi tìm kiếm Boolean

Khởi động: `septic shock OR fluids` cho nhiều kết quả hơn (chỉ cần một trong hai từ). `sepsis` cho nhiều kết quả hơn `sepsis NOT neonatal` (NOT loại bớt bài báo).

Xây chuỗi tìm kiếm: bảng mẫu cho ví dụ xuyên suốt

Khối	Khái niệm	Từ đồng nghĩa (2–4). (M) đánh dấu thuật ngữ MeSH
P	Sốc nhiễm khuẩn	Shock, Septic (M) · septic shock · sepsis
I / E	Chiến lược hạn chế dịch	Fluid Therapy (M) · fluid restriction · restrictive fluid · conservative fluid
O	Tử vong	Mortality (M) · mortality · death

Chuỗi tìm kiếm mẫu (như trong phần trình diễn):

```
("Shock, Septic"[Mesh] OR "septic shock"[tiab] OR sepsis[tiab])
AND ("Fluid Therapy"[Mesh] OR "fluid restrict*"[tiab] OR "restrictive fluid*"[tiab]
  OR "conservative fluid*"[tiab])
AND ("Mortality"[Mesh] OR mortality[tiab] OR death[tiab])
```

Một bộ lọc, và vì sao: loại bài *Randomized Controlled Trial* và *Systematic Review*, vì đây là câu hỏi về điều trị. Các bộ lọc hợp lý khác là *Adult: 19+ years* (đối tượng của câu hỏi) và năm công bố *10 years* (thực hành hiện tại). Tránh *Free full text*, vì bộ lọc này làm mất các bài báo quan trọng.

Chia sẻ chuỗi tìm kiếm: các từ đồng nghĩa cả lớp có thể gợi ý cho khối I: `de-resuscitation[tiab]`, `deresuscitation[tiab]`, `"fluid balance"[tiab]`, `"Water-Electrolyte Balance"[Mesh]`.

Ghi chú cho giảng viên: nếu học viên xây chuỗi tìm kiếm cho Tình huống C (mê sảng) trong phần thực hành thêm của Buổi 1, đây là chuỗi mẫu.

```
(Delirium[Mesh] OR delirium[tiab] OR "acute confusion"[tiab])
AND ("Hip Fractures"[Mesh] OR "hip fracture*"[tiab])
AND (prevent*[tiab] OR "multicomponent"[tiab] OR "non-pharmacological"[tiab] OR
  bundle[tiab])
```

Lỗi thường gặp

- Thiếu ngoặc: `A OR B AND C` được hiểu khác với `(A OR B) AND C`.
- Dùng AND trong một khối (`septic shock AND sepsis`). Các từ đồng nghĩa cần nối bằng OR.
- Thêm một khối cho nhóm so sánh ("usual care"). Khối này không giúp gì và làm mất bài báo.
- Dùng `NOT` để loại một chủ đề mà bài báo chỉ nhắc đến thoáng qua.
- Dùng từ tìm kiếm bằng tiếng địa phương: PubMed chỉ mục tiêu đề và tóm tắt bằng tiếng Anh.

Bài tập 2: Diễn giải (đáp án mẫu)

Phần A

Phiên bản	Nhận định	Vì sao
a)	**Có vấn đề: viết chắp vá**	Cùng cấu trúc và gần như cùng từ ngữ với nguồn; chỉ đổi một từ ("death" thay cho "mortality"). Vẫn là đạo văn dù có trích dẫn.
b)	**Đạt**	Cấu trúc mới, thêm bối cảnh (thuần tập ghép cặp từ hệ thống lưu trữ thông tin, tử vong 28 ngày), giữ từ chừng mực "associated", có số liệu và trích dẫn.
c)	**Có vấn đề: bóp méo nguồn**	"Giving more fluid ... doubles the risk" biến một *mối liên quan* quan sát thành quan hệ nhân quả, và "doubles" (gấp đôi) là phóng đại (HR 2.13 chỉ ở ngày 2; ngày 3 là 1.56). Trích dẫn không sửa được việc trình bày sai.
d)	**Có vấn đề: không trích dẫn**	Lời văn tốt, nhưng trình bày phát hiện của người khác mà không trích dẫn là đạo văn.

Phần B: bản diễn giải mẫu

"Mortality and days alive without organ support at day 28 did not differ between the two groups, although the pilot trial was too small to detect such differences (1)." (Tạm dịch: Tử vong và số ngày còn sống không cần hỗ trợ cơ quan ở ngày 28 không khác nhau giữa hai nhóm, dù thử nghiệm thí điểm quá nhỏ để phát hiện những khác biệt như vậy (1).)

Thế nào là tốt: cấu trúc mới; dữ kiện không đổi (28 ngày, tử vong, số ngày còn sống không cần hỗ trợ sự sống, tương tự nhau); không khẳng định mạnh hơn (**không** viết "hạn chế dịch là an toàn"); có trích dẫn. Thêm "thử nghiệm quá nhỏ" là bối cảnh chính xác lấy từ bài báo (48 người bệnh; không đủ lực thống kê cho tử vong).

Bài tập 3: Phần tóm tắt của Bài báo 1 (đáp án)

Mục	Đáp án (từ phần tóm tắt)
Thiết kế (và làm mù)	Thử nghiệm **thí điểm** đa trung tâm, ngẫu nhiên, có đối chứng; mù đơn (người bệnh và nhà thống kê được làm mù, bác sĩ lâm sàng thì không)
P	Người lớn 18–85 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, trong 24 giờ đầu truyền thuốc vận mạch, tại ba ICU; loại trừ: tổn thương thận cấp cần điều trị thay thế thận, bệnh thận mạn giai đoạn cuối, suy dinh dưỡng nặng
I so với C	Hạn chế dịch tối ưu (giảm dịch duy trì và dịch pha thuốc trong 7 ngày đầu) so với chiến lược truyền dịch chuẩn
Kết cục chính	**Cân bằng dịch tích lũy (ml/kg) trong 5 ngày đầu**, không phải tử vong
Số liệu	1201 người được sàng lọc; 50 người được phân bổ ngẫu nhiên; 2 người rút lui (nhóm chứng); 48 người được phân tích (24 người mỗi nhóm)
Kết quả chính	Trung vị cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5: 6.9 so với 35.0 ml/kg; hiệu số tuyệt đối 13.2 ml/kg (KTC 95% −15.2 đến 41.6), p = 0.42.

Mục	Đáp án (từ phần tóm tắt)
Kết luận	"...did not reduce the overall fluid balance at day 5" (không làm giảm cân bằng dịch chung ở ngày 5)
Khớp với kết quả?	**Có**. KTC chứa 0, và kết luận nói "không làm giảm".
Có spin trong phần tóm tắt?	**Không.** Kết luận của phần tóm tắt khớp với kết quả chính. Spin nằm ở phần *Bàn luận*: tác giả gọi kết quả là "xu hướng không có ý nghĩa thống kê" (non-significant trend) về phía cân bằng dịch thấp hơn. Với p = 0.42 và KTC 95% từ −15.2 đến 41.6 ml/kg, dữ liệu hoàn toàn phù hợp với việc không có khác biệt, nên chữ "xu hướng" gợi ý một tác dụng mà thử nghiệm không chứng minh được.
Đăng ký	ClinicalTrials.gov **NCT04947904** (đăng ký ngày 1 tháng 7 năm 2021, trước khi bắt đầu tuyển chọn vào tháng 9 năm 2021)
Trả lời câu hỏi về tử vong 28 ngày của lớp?	**Không.** Đây là một nghiên cứu thí điểm nhỏ, được thiết kế đủ lực cho cân bằng dịch. Tử vong 28 ngày là kết cục phụ và tương tự nhau giữa hai nhóm: "không có bằng chứng về khác biệt", không phải "không có khác biệt".

Ai làm xong sớm (Bài báo 2): tiêu đề dùng **"Impact"** (tác động, hàm ý nhân quả); kết luận trong phần tóm tắt dùng đúng từ **"associated"** (có liên quan).

Lỗi thường gặp cần sửa khi tổng kết

- Ghi "tử vong" là kết cục chính.
- Chỉ chép giá trị p mà không chép ước lượng kèm KTC 95%.
- Gọi thử nghiệm là "mù đôi". Bác sĩ lâm sàng, người kê dịch, không được làm mù.
- Đọc hai trung vị (6.9 so với 35.0) thành "cân bằng dịch ít hơn năm lần, vậy là có hiệu quả". KTC cắt qua 0.

Bài tập 4: Xây dựng đề cương 2 (thế nào là tốt)

Giảng viên làm mẫu trực tiếp cho ví dụ xuyên suốt (phiên bản thí điểm khả thi A từ Buổi 1). Sau đó mỗi học viên làm tương tự cho câu hỏi của mình. Dùng làm chuẩn chất lượng, không phải làm đáp án. Bài mẫu đi theo các bước của phiếu bài tập.

Phút 0–10: giảng viên trình bày gì

1. Chạy chuỗi tìm kiếm đầy đủ trong phần trình diễn PubMed (`s2_demo_VN.md`, Các chuỗi để sao chép, Bước 3) với bộ lọc RCT và tổng quan hệ thống, người lớn, 10 năm. Ghi lại trên màn hình: cơ sở dữ liệu, ngày, chuỗi tìm kiếm, bộ lọc, số kết quả. Số kết quả thay đổi mỗi ngày, nên đọc trực tiếp trên màn hình.
2. Đọc to và sàng lọc các tiêu đề đầu tiên. Giữ bài ở người lớn bị sepsis hoặc sốc nhiễm khuẩn, có so sánh chiến lược dịch hoặc cân bằng dịch, là thử nghiệm, nghiên cứu thuần tập hoặc tổng quan. Bỏ bài ở trẻ em, bỏng, phẫu thuật, và thử nghiệm so sánh hai loại dịch (tinh thể với keo). Học viên gợi ý bài và từ khóa trong chat.
3. Lưu Boulet 2024 và CLASSIC vào Zotero (*Send to* → *Citation manager*) và cùng điền hai dòng phiếu tổng quan (dòng mẫu bên dưới).
4. Tìm "septic shock" và "fluid" trên ClinicalTrials.gov để chỉ cách tìm thử nghiệm đang tiến hành.

5. Hỏi từ khóa trong chat. Đáp án mẫu: bốn thuật ngữ MeSH ở bước 5 bên dưới.

1. Ghi lại tìm kiếm (cũng là ô "Chuỗi tìm kiếm đã dùng cho tài liệu tham khảo"): PubMed, ngày tìm, chuỗi tìm kiếm từ Bài tập 1, các bộ lọc (loại bài RCT và tổng quan hệ thống, người lớn, 10 năm) và số kết quả. Sau đó kiểm tra ClinicalTrials.gov để tìm các thử nghiệm đang tiến hành.

2. Năm tài liệu tham khảo chính (mẫu)

#	Tài liệu tham khảo	Lý do chọn
1	Boulet N, et al. *Crit Care* 2024;28:429 (RCT thí điểm, n = 48)	Thiết kế và kết cục gần nhất; kết cục chính không khác biệt có ý nghĩa
2	Hyun DG, et al. *Ann Intensive Care* 2023;13:105 (thuần tập ghép cặp)	Cân bằng dịch dương ở ngày 2–3 liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn
3	Meyhoff TS, et al. (CLASSIC) *N Engl J Med* 2022;386:2459–70	RCT lớn, sốc nhiễm khuẩn, không khác biệt về tử vong 90 ngày
4	Shapiro NI, et al. (CLOVERS) *N Engl J Med* 2023;388:499–510	RCT lớn, tụt huyết áp do sepsis, hạn chế dịch so với truyền dịch tự do, không khác biệt về tử vong trước khi ra viện trong 90 ngày
5	Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign guidelines 2021. *Crit Care Med* 2021;49:e1063–e1143	Hướng dẫn hiện hành; cho thấy những điều còn chưa chắc chắn

Ghi chú cho giảng viên: kiểm tra thông tin trích dẫn với PubMed trước khi phát. Học viên phải tự kiểm tra mọi tài liệu tham khảo, đó chính là thói quen cần luyện.

3. Bảng tổng quan tài liệu: dòng mẫu

#	Nghiên cứu	Thiết kế, cỡ mẫu	So sánh	Kết cục chính: kết quả	Hạn chế chính	Vì sao quan trọng với câu hỏi của chúng ta
1	Boulet 2024, *Crit Care*	RCT thí điểm, 3 ICU, 50 người được phân nhóm, 48 người được phân tích	Hạn chế dịch duy trì và dịch pha thuốc trong 7 ngày so với chăm sóc tiêu chuẩn	Cân bằng dịch tích lũy ngày 5: trung vị 6.9 so với 35.0 ml/kg, p = 0.42, không khác biệt có ý nghĩa	Cỡ mẫu nhỏ, không đủ lực cho tử vong, bác sĩ không được làm mù	Thiết kế và kết cục gần nhất với nghiên cứu thí điểm của chúng ta
2	Hyun 2023, *Ann Intensive Care*	Thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng, hệ thống lưu trữ thông tin (registry) đa trung tâm, 20 bệnh viện, 2516 người bệnh	Cân bằng dịch tích lũy dương so với âm vào cuối ngày ICU thứ 1, 2 hoặc 3	Tử vong 28 ngày: HR 1.17 (KTC 95% 0.85 đến 1.60) ở ngày 1, 2.13 (1.48 đến 3.06) ở ngày 2, 1.56 (1.10 đến 2.22) ở ngày 3	Nghiên cứu quan sát, có thể bị nhiễu	Cân bằng dịch có liên quan với tử vong, nên đáng để giảm

#	Nghiên cứu	Thiết kế, cỡ mẫu	So sánh	Kết cục chính: kết quả	Hạn chế chính	Vì sao quan trọng với câu hỏi của chúng ta
3	Meyhoff 2022, *N Engl J Med* (CLASSIC)	RCT, 1554 người lớn bị sốc nhiễm khuẩn	Hạn chế dịch so với dịch truyền tĩnh mạch tiêu chuẩn	Tử vong 90 ngày 42.3% so với 42.1%, không khác biệt	Bác sĩ không được làm mù	Hạn chế dịch không làm thay đổi tử vong trong một thử nghiệm lớn
4	Shapiro 2023, *N Engl J Med* (CLOVERS)	RCT, 1563 người lớn bị tụt huyết áp do sepsis	Hạn chế dịch (dùng vận mạch sớm hơn) so với truyền dịch tự do	Tử vong trước khi ra viện về nhà trong 90 ngày: 14.0% so với 14.9%, không khác biệt	Không làm mù, chỉ giai đoạn đầu của điều trị	Khẳng định kết quả của CLASSIC ở một quần thể khác
5	Evans 2021, *Crit Care Med* (Surviving Sepsis Campaign)	Hướng dẫn quốc tế	Không áp dụng	Không có khuyến cáo về hạn chế dịch so với truyền dịch tự do sau hồi sức ban đầu (chưa đủ bằng chứng)	Ý kiến chuyên gia khi bằng chứng còn yếu	Cho thấy điều còn chưa chắc chắn mà nghiên cứu thí điểm của chúng ta giải quyết

4. Đặt vấn đề (khoảng 300 từ, ba đoạn)

1. *Điều đã biết:* Sốc nhiễm khuẩn là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại khoa hồi sức tích cực (ICU). Dịch sớm giúp phục hồi tưới máu, nhưng dịch truyền sau những giờ đầu thường dẫn đến cân bằng dịch dương, có liên quan với tử vong cao hơn trong các nghiên cứu quan sát (1).

2. *Điều chưa biết:* Hai thử nghiệm ngẫu nhiên lớn cho thấy hạn chế dịch không làm thay đổi tử vong (2,3). Một thử nghiệm thí điểm gần đây nhắm vào dịch không nhằm hồi sức không làm giảm có ý nghĩa cân bằng dịch ở ngày 5 (4). Vì vậy, vẫn chưa rõ có thể giảm cân bằng dịch một cách ổn định trong chăm sóc thường quy hay không.

3. *Mục đích và mục tiêu:* Trong thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm này, chúng tôi nhằm đánh giá liệu quy trình hạn chế dịch có làm giảm cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5 so với chăm sóc thường quy ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn hay không. Mục tiêu chính là so sánh cân bằng dịch ngày 5 giữa hai nhóm. Mục tiêu phụ là đánh giá tính khả thi của một thử nghiệm lớn hơn.

Tài liệu tham khảo, theo thứ tự trích dẫn lần đầu: (1) Hyun 2023, (2) CLASSIC, Meyhoff 2022, (3) CLOVERS, Shapiro 2023, (4) Boulet 2024.

Nguyên tắc khoa học: phần Đặt vấn đề không bao giờ chứa số liệu hay kết quả của chính bạn (kể cả kết quả đánh giá thực hành, audit, tại khoa). Chúng thuộc về phần Kết quả. Số liệu địa phương chỉ được dùng khi đã được công bố, kèm trích dẫn.

5. Tên đề tài tạm thời và từ khóa

Tên đề tài tạm thời	*Restrictive versus usual fluids in adults with septic shock: a pilot randomised trial*
Số từ	13

Từ khóa	1. Fluid Therapy 2. Water-Electrolyte Balance 3. Critical Care 4. Vasoconstrictor Agents (thuật ngữ MeSH chưa có trong tên đề tài)

Hướng dẫn phản hồi khi đọc bản nháp (không chấm điểm)

Thành phần	Tốt	Cần cải thiện
Tìm kiếm	Ghi lại chuỗi tìm kiếm, cơ sở dữ liệu, ngày, bộ lọc và số kết quả; ngoặc đúng	"Chúng tôi tìm trên Google"; không có ngày; AND trong một khối
Tài liệu tham khảo	5 tài liệu, phù hợp, có thiết kế tốt nhất hiện có, xuất sang phần mềm quản lý tài liệu tham khảo	Website, chỉ có sách giáo khoa, gõ tay, chưa đọc
Bảng tổng quan tài liệu	Cùng các cột cho mọi bài báo; cột hạn chế được điền	Chép câu từ phần tóm tắt
Đặt vấn đề	Điều đã biết, rồi khoảng trống, rồi câu hỏi và mục tiêu; mỗi dữ kiện đều có trích dẫn	Liệt kê tài liệu; có số liệu hay kết quả của chính mình; số liệu địa phương chưa công bố
Tên đề tài và từ khóa	10–16 từ; thấy rõ P, I/E, C và thiết kế; từ ngữ chừng mực; từ khóa bổ sung MeSH chưa có trong tên đề tài	"Fluids in the ICU"; viết tắt; "impact of" cho thiết kế quan sát
Liêm chính	Lời của chính mình, mọi khẳng định đều có trích dẫn	Câu dán nguyên từ phần tóm tắt

---

Câu hỏi cuối buổi: đáp án

1. **OR** cho nhiều kết quả hơn.
2. Kết cục chính của Bài báo 1 là **cân bằng dịch tích lũy ở ngày 5 (ml/kg)**, không phải tử vong.